

# **Livello 2 — Policy Brief**

Psicologo di Base in Puglia — Studio Integrale HTA

# Lo Psicologo di Base in Puglia — Policy Brief

---

*Studio Integrale di Health Technology Assessment · L.R. 19 luglio 2023, n. 11 · Regione Puglia*

## In sintesi (BLUF)

Lo Psicologo di Base in Puglia produce un verdetto tripartito nettamente favorevole: nello scenario di copertura intermedio (775 professionisti), a un costo di 40,5 milioni di euro l'anno corrispondono 47,0 milioni di risparmi sanitari diretti e 27,0 milioni di benefici indiretti — un ROI (ritorno sull'investimento) lordo di 1:6,6 — con un costo per anno di vita guadagnato in buona salute di circa 9.800 euro, ben sotto le soglie di accettabilità correnti. Tre giudizi distinti — fiscale, sanitario, sociale — mai sommati in una cifra unica, ciascuno solido sul proprio piano. Si raccomanda l'attuazione a regime della legge regionale 11/2023 secondo lo scenario di copertura intermedio (775 Psicologi di Base), con dispiegamento scaglionato sulle sei Aziende Sanitarie Locali.

## Il contesto e il problema

La Puglia conta circa 3,89 milioni di residenti. Di questi, tra 780.000 e 1.160.000 convivono con un disagio psichico comune (ansia, depressione) che le cure primarie attuali non intercettano in modo strutturato, in assenza di una figura psicologica stabile al primo contatto. L'articolo 32 della Costituzione e la definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (1946) fondano l'obbligo di intervenire. La legge regionale 19 luglio 2023, n. 11 ha già tradotto questo fondamento in norma, istituendo il Servizio di Psicologia di Base e rendendo la Puglia la prima regione italiana a farlo. Resta da decidere con quale intensità e in quali tempi attuarla.

## Le opzioni a confronto

Lo studio ha valutato la riforma su tre scenari di copertura, oltre allo status quo. Il fabbisogno regionale a regime, calcolato sul rapporto di un Psicologo di Base ogni 4.400–4.900 abitanti, si colloca tra 800 e 880 professionisti. I risparmi sanitari diretti sono qui riportati secondo l'ancoraggio metodologico più recente adottato dallo studio (OCSE, 2026), che sostituisce l'ancoraggio precedente (Chisholm et al., 2016).

**Opzione 0 — Status quo (nessuna attuazione).** Costo diretto aggiuntivo nullo, ma nessun beneficio. Il divario di trattamento resta invariato, senza riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, della spesa

farmaceutica inappropriata o della mobilità sanitaria passiva. Fattibilità massima, efficacia ed equità minime.

**Opzione A — Copertura minima (620 Psicologi di Base).** Risparmi sanitari diretti stimati in 23,5 milioni di euro l'anno. Fattibilità di reclutamento più agevole nel breve periodo, ma sotto il fabbisogno prudenziale stimato (800–880). Copertura parziale della domanda, equità territoriale più debole nelle aree a maggiore dispersione.

**Opzione B — Copertura intermedia (775 Psicologi di Base).** Costo di regime 40,5 milioni di euro l'anno. Risparmi sanitari diretti stimati in 47,0 milioni, benefici indiretti in 27,0 milioni (benefico totale 74,0 milioni, ROI lordo 1:6,6). Prossima al limite inferiore del fabbisogno prudenziale (800–880): equilibrio ragionevole tra fattibilità di reclutamento e copertura della domanda.

**Opzione C — Copertura piena (900 Psicologi di Base).** Risparmi sanitari diretti stimati in 79,5 milioni di euro l'anno, il valore più alto dei tre scenari. Massima efficacia ed equità territoriale, ma la fattibilità di reclutamento a regime è la più esposta al rischio attuativo.

Su tutti e tre gli scenari, il costo per anno di vita guadagnato in buona salute migliora al crescere della copertura (dai circa 11.500 euro dell'Opzione A ai circa 7.200 euro dell'Opzione C, contro i 9.800 euro dell'Opzione B). Resta in ogni caso ben al di sotto della soglia italiana di costo-efficacia di 40.000 euro/QALY (anno di vita ponderato per la qualità). Le tre opzioni si distinguono per intensità di copertura, non per la direzione del giudizio complessivo, che è favorevole in tutti e tre i casi.

*Nota metodologica:* il costo diretto di regime per le Opzioni A e C non è ancora riconciliato in modo puntuale con l'ancoraggio OCSE 2026 nella documentazione ricevuta (la tabella di riferimento riporta un costo di 40,5 milioni di euro in tutti e tre gli scenari, mentre altre sezioni del Tomo I indicano una fascia di costo crescente con la copertura, 43–47 milioni). Si veda `_meta/status-tracker.md`. La raccomandazione per l'Opzione B non dipende da questa riconciliazione, poiché è la sola cifra di costo pienamente confermata nella documentazione.

## La raccomandazione

Si raccomanda l'**Opzione B (775 Psicologi di Base)**, come punto di equilibrio tra fattibilità attuativa e copertura del fabbisogno prudenziale, con dispiegamento scaglionato sulle sei Aziende Sanitarie Locali pugliesi e nei quarantacinque distretti, secondo la sequenza già prevista dallo studio (Parte XIV, Attuazione, fattibilità e sostenibilità). Il rapporto convenzionale — analogo a quello già adottato da altre categorie professionali sanitarie — è l'assetto contrattuale indicato come più fattibile.

## Le incertezze dichiarate

- I risparmi sanitari diretti, pur presenti e ricalcolati al rialzo dall'ancoraggio OCSE 2026, non hanno raggiunto significatività statistica nel trial di riferimento (Unützer et al., 2008) se considerati isolatamente: il saldo fiscale positivo va letto con questa cautela dichiarata dallo studio stesso.
- Il fabbisogno di personale (800–880 professionisti) dipende da un rapporto di copertura (1:4.400–4.900) che lo studio dichiara esso stesso come banda prudenziale, non come cifra puntuale.
- Il costo diretto di regime per le Opzioni A e C non è ancora riconciliato in modo puntuale tra le diverse sezioni del Tomo I (si veda la nota metodologica sopra).
- La Parte VI dello studio (efficacia ed evidenza clinica) risulta, alla data di questa redazione, ancora in stato di avanzamento parziale rispetto alle altre parti del Tomo I.
- Il rischio attuativo principale è il reclutamento: un fabbisogno di 620–900 professionisti presuppone la disponibilità di personale psicologico qualificato in misura sufficiente sull'elenco regionale.

## Per approfondire

Per la sintesi narrativa completa si veda il Livello 3 — Executive Summary ([\\_livelli-piramide/livello-3-executive-summary.md](#)); per il quadro metodologico completo (domini HTA, modello economico, protocollo dell'incertezza) il Livello 4 — Sintesi Tecnica ([\\_livelli-piramide/livello-4-sintesi-tecnica.md](#)); per l'analisi integrale, il Tomo I ([tomo-1-puglia/opera-integrale-puglia.docx](#)), Parte IV (revisione metodologica OCSE 2026) e Parti VII–XI.